·临床护理·

高压氧护理干预在脑外伤失语症中的应用效果

李芳[1]，杨瑞玲[2]

1.寿光市中医医院高压氧科，山东　寿光　262700；2.山东省寿光中医医院急诊科

摘要：目的 探讨高压氧护理干预在脑外伤失语症中的应用效果，以提高患者的康复效果提供帮助。**方法** 选择2022年11月—2023年11月寿光市中医医院收治的62例脑外伤失语症患者，按随机数字表法分为观察组和对照组各31例。对照组给予常规护理，观察组在其基础上给予高压氧护理。比较两组患者康复情况、失语症占比、情绪状态、依从程度、生活质量。**结果** 护理后5、10、15 d，两组CRRCAE评分较护理前提高，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。观察组完全性、运动性、感觉性、命名性失语症的患者总占比为19.35%，低于对照组的45.16%，差异有统计学意义（$P<0.05$）。护理后，两组SAS、SDS评分较护理前降低，且观察组低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。观察组患者总依从性为96.77%，高于对照组的80.65%，差异有统计学意义（$\chi^2=4.026$，$P<0.05$）。观察组SF-36中8项评分均高于对照组，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。**结论** 高压氧护理干预能提高脑外伤失语症患者的康复效果，减少不同类型失语症的占比，患者情绪状态更佳，依从程度及生活质量更高，值得推广应用。

关键词：高压氧护理；脑外伤失语症；康复情况；依从程度；生活质量

中图分类号：R473.6　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1003-5052(2025)04-206-03　　**DOI:**10.16286/j.1003-5052.2025.04.076

脑外伤失语症是临床上比较常见的病症之一，是以脑外伤为原发疾病，由于脑组织中与语言有关的部位产生损失从而造成语言障碍的一种病症，严重影响患者的日常生活，且可能诱发其他疾病，因此要及时进行干预治疗与护理[1]。在脑外伤失语症患者的治疗过程中，对患者采取一个有效的护理干预能够有效提高治疗效果。常规的护理方法较单一，对于促进患者语言功能恢复的效果不理想，对脑外伤失语症患者实行高压氧护理干预能够有效促进患者语言功能恢复，帮助患者改善病情，提高护理效果[2]。鉴于此，本研究按随机数字表法对62例脑外伤失语症患者进行研究，探讨高压氧护理的具体影响，报告如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选择2022年11月—2023年11月我院收治的62例脑外伤失语症患者，按随机数字表法分为观察组和对照组各31例。对照组男性15例，女性16例；年龄18~50岁，平均(34.10±3.02)岁；病程2~8个月，平均(6.93±1.02)个月。观察组男性15例，女性16例；年龄18~50岁，平均(34.13±3.05)岁；病程2~8个月，平均(6.89±1.01)个月。两组患者一般资料比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。本研究经医学伦理委员会批准同意。

1.2　纳入、排除标准　纳入标准：(1)均首次出现脑外伤失语症；(2)患者信息齐全；(3)患者及家属知晓研究。排除标准：(1)中途退出者；(2)认知、精神障碍者；(3)器官衰竭者。

1.3　方法　对照组给予常规护理，对患者病情进行了解，给予患者相关药物帮助患者减少感染等各种并发症的出现。观察组在其基础上给予高压氧护理。具体护理措施如下：(1)入舱前护理。护理人员要详细了解患者的身体情况，尤其是第一次进行高压氧治疗的患者，并协助医生把握好患者进行高压氧治疗的禁忌证和适应证，对患者进行高压氧治疗的有

作者简介：李芳，本科，主管护师，主要从事高压氧护理工作

通信作者：李芳，E-mail：15863295333@163.com

医学食疗与健康，2020，18(22)：196-198.

[5] 胡苹. 优质护理在手术室护理中的应用分析 [J]. 黑龙江中医药，2021，50(5)：239-240.

[6] 马利君. 兰州市第二人民医院老年住院患者护理服务质量调查及影响因素研究[J].甘肃中医药大学学报，2020，37(5)：105-110.

[7] 解忠丽.持续质量改进在医院感染管理中的效果研究[J].中国社区医师，2022，38(5)：162-164.

[8] 高淑惠.手术室细节护理管理在医院感染控制中的应用分析[J].中国社区医师，2022，38(9)：123-125.

[9] 苏琦.手术患者医院感染与手术室护理管理的相关性分析[J].中国医药指南，2021，19(32)：194-195.

责任编辑：刘美英，校对：董莉

中国知网　https://www.cnki.net

效性和价值进行评估，并提高患者和家属对高压氧治疗的了解程度，提高患者的配合性和依从度，叮嘱患者在治疗前洗头洗澡。(2)入舱后护理。患者入舱后，护理人员要保持舱内压力升高后保持匀速，同时叮嘱患者戴好面罩吸氧，注意帮患者做好保暖，并对患者做好心理干预，帮助患者舒缓压力，减轻紧张等不良情绪，对患者进行加压处理前要告知患者张嘴，鼓腮，避免患者出现不适。(3)出舱后护理。患者出舱后护理人员要密切监测患者的各项生命体征，了解患者治疗前后的变化，指导患者接受理解训练，提高患者认知程度，由简到难，并不断鼓励患者，进而提高患者语言表达能力。

1.4 观察指标 (1)康复情况。给予患者中国康复研究中心汉语标准失语症检查（China Rehabilitation Research Center aphasia examination，CRRCAE）[3]评估，分为理解、复述、说、出声读、阅读理解、抄写、描写、听写和计算 9 大项，分数越高，康复效果越好。(2)失语症占比。记录完全性、运动性、感觉性、命名性失语症的患者例数，并分别计算占比。(3)情绪状态。给予抑郁(SDS)[4]与焦虑(SAS)自评量表[5]，分值 80 分、100 分，临界值分别为 53 分、50 分，分数越高，情绪状态越差。(4)依从程度。给予自制依从量表[6]评估患者对护理措施的依从程度，0~100 分，>75 分记为高度依从，75~50 分为中度依从，50~25 分为轻度依从，<25 分为不依从。(5)生活质量。给予生活质量量表(SF-36)[7]评估，8 个维度，均 0~100 分，分数越高，质量越高。

1.5 统计学处理 采用 SPSS 25.0 软件对研究数据进行统计学分析，计量资料用 $\bar{x}\pm s$ 表示，采用 t 检验，计数资料用 n(%)表示，采用 χ^2 检验，$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组康复情况比较 护理后 5、10、15 d 两组 CRRCAE 评分较护理前提高，且观察组高于对照组，差异均有统计学意义($P<0.05$)，见表 1。

表 1 观察组与对照组康复情况比较 ($\bar{x}\pm s$，分)

组别	例数	护理前	护理后 5 d	护理后 10 d	护理后 15 d
观察组	31	36.42±4.31	46.24±5.11	63.09±4.20	75.39±5.27
对照组	31	36.39±4.40	40.09±6.09	56.84±5.33	60.01±6.18
t 值		0.027	4.307	5.128	10.543
P 值		0.979	<0.01	<0.01	<0.01

2.2 两组失语症占比比较 观察组完全性、运动性、感觉性、命名性失语症的患者总占比为 19.35%，低于对照组的 45.16%，差异有统计学意义($P<0.05$)，见表2。

表 2 观察组与对照组 失语症占比比较 [n(%)]

组别	例数	完全性	运动性	感觉性	命名性	总占比
观察组	31	1(3.23)	2(6.45)	2(6.45)	1(3.23)	6(19.35)
对照组	31	4(12.90)	4(12.90)	3(9.68)	3(9.68)	14(45.16)
χ^2 值						4.724
P 值						0.030

2.3 两组情绪状态比较 护理前，两组 SAS、SDS 评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；护理后，两组 SAS、SDS 评分较护理前降低，且观察组低于对照组，差异均有统计学意义($P<0.05$)，见表 3。

表 3 观察组与对照组情绪状态比较 ($\bar{x}\pm s$，分)

组别	例数	SAS 评分		SDS 评分	
		护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	31	63.82±3.14	40.27±2.35[a]	64.82±4.35	38.39±1.82[a]
对照组	31	63.91±3.15	45.35±2.72[a]	65.02±4.36	43.38±1.95[a]
t 值		0.113	7.869	0.181	10.416
P 值		0.911	<0.01	0.857	<0.01

注：与同组护理前比较，[a]$P<0.05$。

2.4 两组依从程度比较 观察组患者总依从性高于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)，见表4。

表 4 观察组与对照组依从程度比较 [n(%)]

组别	例数	高度依从	中度依从	轻度依从	不依从性	总依从性
观察组	31	23(74.19)	4(12.90)	3(9.68)	1(3.23)	30(96.77)
对照组	31	17(54.84)	6(19.35)	2(6.45)	6(19.35)	25(80.65)
χ^2 值						4.026
P 值						0.045

2.5 两组生活质量比较 观察组 SF-36 中 8 项评分均高于对照组，差异均有统计学意义($P<0.05$)，见表5。

表 5 观察组与对照组生活质量比较 ($\bar{x}\pm s$，分)

组别	例数	社会功能	生理功能	情感职能	生理职能	精神健康	活力	总体健康	躯体疼痛
观察组	31	88.28±1.91	89.43±1.99	90.34±1.88	89.96±1.39	89.82±1.39	89.99±1.85	90.06±2.59	89.73±1.86
对照组	31	84.48±2.04	84.28±2.02	84.38±2.14	83.18±2.01	83.82±2.01	85.14±2.15	84.58±2.93	83.15±2.03
t 值		7.571	10.112	11.650	15.447	13.670	9.520	7.802	13.306
P 值		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

中国知网 https://www.cnki.net

3 讨 论

失语症是患者受到脑外伤后，脑组织中与语言相关的部位发生损伤，从而导致患者后天语言功能丧失或出现障碍的一种病症[8]。除了要积极治疗,护理措施同样重要[9]。本研究中,两组 CRRCAE 评分较护理前提高,且观察组高于对照组。说明对脑外伤失语症患者实行高压氧护理干预，患者的康复情况更好，分析原因在于护理人员会在患者入舱前后对患者进行相应的护理,提高高压氧治疗效果,同时会在出舱后对患者进行理解训练，因此患者语言功能恢复更好[10]。

本研究中,观察组完全性、运动性、感觉性、命名性失语症的患者总占比为 19.35%，对照组为 45.16%,观察组低于对照组。说明对脑外伤失语症患者实行高压氧护理干预，脑外伤患者失语症占比更小,分析原因在于通过高压氧护理干预,护理人员会对患者进行接受训练，根据患者病情进行难易程度的调整，患者语言功能恢复得更好，失语症占比更小。本研究中,观察组与对照组 SAS、SDS 评分较护理前降低,且观察组低于对照组。说明对脑外伤失语症患者实行高压氧护理干预,患者的情绪状态更佳,分析原因在于护理人员会对患者进行心理干预，帮助其消除恐惧,紧张等不良情绪,增强患者信心,因此患者的情绪状态更佳。

本研究中,观察组患者依从性为 96.77%,对照组为 80.65%,观察组高于对照组。说明对脑外伤失语症患者实行高压氧护理干预,患者的依从度更高,分析原因在于护理人员会对患者进行心理干预，给予患者鼓励和安慰,帮助患者树立信心,建立良好的护患关系,因此患者依从度更高。本研究中,观察组 SF-36 中 8 项评分均高于对照组。说明对脑外伤失语症患者实行高压氧护理干预患者的生活质量更高，分析原因在于通过高压氧护理干预，患者的语言功能恢复得更好,情绪状态更佳,因此生活质量更优。

综上所述，对脑外伤失语症患者进行科学护理是十分重要的,常规护理主要以基础护理为主,其护理措施的设置以执行医嘱为主，虽适用于大多数患者,帮助患者提高护理效果,但同样存在缺乏针对性的问题。高压氧护理干预,是指在患者入舱前后和出舱后对患者进行护理干预，能够结合患者的具体病症,制定更加详细、全面的护理措施,能够有效改善患者不良临床症状,促进语言功能的恢复。此外,大多数失语症患者因缺乏对疾病的正确了解，易出现过度焦虑、担忧等负性心理,这种消极的心理状态会影响患者的护理配合。而高压氧护理中增加了对患者情绪方面的护理措施,使其情绪状态更佳,继而提高患者对护理措施的依从度，其生活质量也得到提高,值得推广应用。

参考文献

[1] 郭秧秧,王向征,刘寒松,等.高压氧联合醒脑静治疗重型颅脑外伤患者期间应用早期康复护理的干预效果[J].中国药物滥用防治杂志,2023,29(9):1648-1652.

[2] 刘姗姗,张丽颖.预见性护理对脑卒中患者术后康复的影响[J].中国城乡企业卫生,2022,37(2):203-204.

[3] 王海玲,杨晶,李娜.基于分流早期预警评分建立护理记录模板在高压氧治疗颅脑损伤患者中的应用 [J]. 中国病案,2023,24(6):104-106.

[4] 段雪梅,户明君,张娟.高压氧护理干预对伴眩晕的全聋型突发性聋患者的应用效果研究[J].临床医学工程,2023,30(4):533-534.

[5] 曾迎春,曾玲晖,张国龙,等.基于沉浸式虚拟现实的肿瘤相关性失语症康复训练系统的设计与可行性研究 [J]. 中国护理管理,2022,22(8):1242-1246.

[6] 张罗侠,李蕾,罗应菊,等.中医综合康复护理对脑卒中运动性失语患者语言能力及心理状态的影响[J].四川中医,2023,41(2):216-219.

[7] 王晶,张晓玲,董悦.高压氧配合早期综合康复护理对缺氧缺血性脑病早产儿行为智能发育及后遗症的影响[J].天津护理,2022,30(2):169-173.

[8] 张慧,夏茂红.词汇图表疗法对高血压脑出血术后失语症患者语言功能的影响[J].当代护士(上旬刊),2023,30(1):96-98.

[9] 刘娜. 中医整体护理结合优质护理高压氧治疗的缺血缺氧性脑病新生儿护理中的效果[J].实用中医内科杂志,2022,36(1):90-92.

[10] 胡含波,何小俊,李薇薇,等.远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展[J].护理研究,2022,36(18):3291-3294.

责任编辑:刘美英,校对:戚文彬

中国知网 https://www.cnki.net